

제 4장 갱년기와 폐경 관련 질환

1절 갱년기 증후군 및 폐경기증후군

- **폐경**: 생물학적 개념으로, 난포 기능의 소실로 인해 일어나는 월경의 영구적인 정지

ex. 난포가 기능을 하는데 월경을 안한다면? -> 자궁적출한 것(폐경 X)
단순히 무월경이 아닌, 난포기능의 소실로 인한 것을 의미

① 자연폐경: 자연적인 폐경

② 유도폐경: 질병치료 과정에 의한 수술이나 항암치료 등으로 유발

- 갱년기

- 폐경 전과 폐경기 동안, 폐경기 이후의 일정기간을 포함하는 폐경전 후기
- 여성일생에서 생식능력이 끝나는 시기라는 생물학적 개념 + 사회·문화적 개념 내포

최종월경								
Stage	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2
용어	가임기 (Reproductive)			폐경 이행기 (Menopausal Transition)		폐경 후기 (Postmenopause)		
	초기	Peak	후기	초기	후기	초기	후기	
	주 폐경기(Perimenopause)							
기간	다발함			다발함		1년	4년	사망까지
월경주기	다양~ 규칙적	규칙적		다양(7일 이상)	2회 이상 무월경	무월경 12개월	없음	
FSH	정상		상승	상승		상승		

30대 후반부터 월경주기가 조금씩 짧아짐.

폐경을 증상적으로 진단 시 최종 월경 이후로 1년 이상 하지 않은 상태

1. 갱년기

1) 폐경 이행기

- 폐경 전 약 2~8년으로, 평균 5년 정도 지속
- 난소기능의 변화로 인한 다양한 신체적, 정신적 변화가 특징적 (FSH 수치 상승으로 인한 난포의 조기 동원 -> 월경 주기 짧아짐)
- 40대 중후반에서 미세한 증상을 나타내며 점차 시작됨
- 증상은 환자와 의사 모두에 의해 무시되거나 간과되는 경우도 있고, 스트레스로 인한 증상과 에스트로겐 감소로 인한 증상이 구별하기 힘든 경우도 있음
- > 따라서, 스트레스와 에스트로겐 결핍을 서로 연관하여 고려 必
- 폐경 이행기의 가장 뚜렷한 증상은 **생리불순**
- 폐경기 전 4년 동안 90%의 여성에서 나타남
- 비정상 자궁 출혈은 자궁절제술을 시술받는 가장 흔한 원인 중 하나 이므로, 주의 必

2) 폐경

① 정의 : 월경의 영구적 중단

- 마지막 월경시기로부터 12개월 이상 무월경이 지속되었을 때, 폐경으로 정의
- 폐경의 시점은 후향적으로 결정 (12개월 정도는 지나봐야 아니까!)

② 연령 : 평균 51세 (한국의 경우 49.7세로 약 50세)

③ 폐경연령의 결정인자

- 유전적 요인으로 결정됨
- 인종, 영양상태, 사회경제학적 위치, 초경연령, 과거 배란 횟수, 이전에 배란된 난포 수는 영향 X
- 흡연 여성, 미경산부, 자궁을 완전히 절제한 여성에서 일찍 일어나는 경향
- 영양상태 불량, 마른여성, 잦은 음주(혈중 E 농도 높임), 유전요인, 흡연도 영향

④ 진단

- 전통적으로 후향적으로 진단
- 저에스트로겐혈증의 증상과 FSH 40mIU/ml 이상인 무월경일 때 폐경이 진단 ★
- └ 폐경 후 혈중 E2 농도 : 10~20pg/ml ★(5미만까지도 나타나기도 함)
- 최근에는 AMH를 이용하여 추정
- 한국여성의 AMH 폐경이행기 역치는 AMH 0.5ng/ml. 그 이하는 거의 폐경으로 접근
- 안면홍조 같은 증상의 관찰로 예측 가능
- 안면홍조는 폐경기의 급성증상으로, E가 떨어지는 폐경기 급성기에 가장 강하게 나타남

3) 폐경 이후

- **난소의 기능이 정지된 상태로**, 여성 평균 수명의 1/3 이상 차지
- 폐경기 이후 수년이 지나 에스트로겐 결핍으로 **골다공증, 심혈관계 질환** 등이 발생

- 골다공증, 심혈관계 질환 등은 에스트로겐 결핍이 급격하지 않고 장기적이기 때문에 수년이 지나야 발생하는 것으로, 심혈관계 질환이 E 결핍으로 인한 것인지 고령과 연관된 것인지를 혼동 가능
- 특히 골다공증은 막연한 요통 외에 뚜렷한 임상 증상 X -> 모호함
- 폐경의 영향을 모호하게 만드는 또 다른 요소: 난소 기능의 소실이 절대적인 E 결핍으로 나타나지 않음. 부신과 난소에서 안드로겐의 말초 전환으로 인해 E 생성 가능

4) 조기폐경

- **40세 이전에 폐경이 초래되는 경우**로, 보통 특발성으로 자연적·화학요법·수술에 의해 초래됨
- 35세 이전 나타났을 경우 **mosaicism**(모자이크 현상으로, 다운증후군의 유형)과 같은 유전적 소인 배제를 위한 염색체 검사
- 조기폐경을 경험한 여성의 심혈관질환 위험도 = 50세에 폐경을 겪은 여성의 1.38배
- 양측난소절제술로 인한 조기폐경된 경우 심혈관질환 위험도 = 4.55배
- 전자궁절제술을 시행하는 경우 약 40%에서 양측 난소를 제거하게 되는데, 이 경우 증상이 급격하게 초래되어 안면홍조가 뚜렷하고 몇 달 후 질의 위축증상을 초래함
- 정신적 치료(심리적 지지)와 호르몬 보충요법 필요
- 장기간 수술적 조기폐경 시 심혈관 질환뿐만 아니라 골다공증의 빈도 높아짐

2. 갱년기의 호르몬 변화

1) 폐경이행기

- 난포가 성선자극호르몬 자극에 대해 저항 증가 → 성선자극호르몬인 FSH, LH 농도 ↑
- 저에스트로겐 환경에 의해 야기되는 성선자극호르몬의 맥동적 분비 → 안면홍조
- 안면홍조는 체간의 중심부에서 실질적인 변화로 인해 나타남
- 여성 호르몬, 중추성 신경전달물질 등이 원인으로 고려됨
- 대부분 여성 배란빈도 ↓, 배란되더라도 LH 농도가 젊은 여성에 비해 낮음
- 폐경기 전후에 생리주기 불규칙

2) 폐경

E	- 난소의 E 분비는 매우 적으나 혈중 E 수준은 측정될 정도로 유지 (부신/난소의 안드로겐이 말초근육이나 지방조직에서 E1로 전환되기 때문) - 폐경 전 E2 혈중농도: 40~300pg/ml - 폐경 후 E1 + E2 혈중농도: 100pg/ml - 폐경 후 대부분의 에스트로겐은 부신피질과 난소에서 유래된 androstenedione이 말초조직, 즉 근육과 지방 조직에서 전환된 것 - 폐경 후 비만 여성은 혈중 에스트로겐 ↑ 유방암/자궁내막암 위험 ↑ - 마른 여성은 혈중 에스트로겐 ↓ 골다공증 위험 ↑
---	---

	(but, 경향성일 뿐이지 에스트로겐 부족이 골다공증의 절대적인 인자 X) (골다공증 추가 내용은 아래에..)
P	- 폐경 후 P 생산 중단 → 월경전증후군 소실 - 프로게스테론의 감소는 자궁내막 및 유방에 영향을 줌 - 폐경 후 감소 시 자궁내막암/자궁내막증식증/유방암 위험률 증가 가능 - 자궁내막증식증, 에스트로겐의 단일노출을 위한 자궁내막의 지속적인 증식 자체가 암의 위험 요인 - 유방조직은 성선호르몬에 예민하게 반응하므로, 지속적인 E의 자극에 의해 유방암 유발 가능
안드로겐	- 난소에서 분비되는 제3의 스테로이드 호르몬으로 주로 테스토스테론과 안드로스텐디온 - 폐경 전: 난소에서 혈중 ADD의 50%, T의 25% 생성 - 폐경 동안: 혈중 ADD 농도 0.53ng/ml, T 농도 0.23ng/ml - 폐경 후: 난소/부신에서 안드로겐 생산 감소되어 총 안드로겐 감소 - 총량보다도 안드로겐과 여성호르몬 비율 자체를 보면 남성호르몬이 더 우위가 됨 → 폐경 이후 조금 더 남성화되는 경향성 - 폐경 전과 폐경 후 난소의 스테로이드 생성기능이 존재해서 난소 절제 시 안드로겐의 급격한 감소

- 폐경기 가장 많이 영향을 받는 호르몬은 에스트로겐과 안드로겐

- 골다공증 관련 -

- 갑자기 꽃피셔서 진행.

- 골다공증이 있는 사람들은 뼈에 무게를 싣는 운동을 해야 한다.
- but, 이런 사람들이 과연 관절이라고 멀쩡할까? 당연히 아니다.
- 이렇기에 물속에 들어가서 하는 운동이 관절 보호 측면에서는 좋은데, 또 골다공증에는 무게가 실리지 않기 때문에 큰 도움이 되지 않는다.
- 아령이라도 들게 하고 걷게 하는게 낫다.

3. 호르몬 보충요법

1) 개요 및 역사

1970년대	에스트로겐 단독 요법 사용
1980년대 ~ 1990년대	에스트로겐 단독요법이 자궁내막암 증가시킨다고 밝혀짐 -> P와 병용 (심혈관질환, 골다공증 예방 기대)
1998년 ~ 2002년	에스트로겐 - 프로게스테론 복합제제 복용 시 심혈관 질환 예방 X 오히려 복용 초기에는 위험 증가시켜 사용 중단됨
2004년	에스트로겐 단독요법 중단

2) 목적

- 폐경을 난소 부전에 의한 내분비 질환으로 보게 되어 에스트로겐 보충을 위해 하게 됨
- 폐경 후 호르몬 요법의 목적: 폐경 후 여성호르몬의 감소로 인한 증상 및 육체 영향을 경감시키기 위해 에스트로겐 투여

3) 폐경 후 호르몬 요법의 금기증

절대적인 금기증	상대적인 금기증
① 현재 유방암 또는 자궁내막암으로 진단되었거나 의심 ② 진단되지 않은 질 출혈 ③ 활동성 혈전색전증 ④ 활동성 간질환 또는 담낭질환을 앓고 있는 경우	① 심질환 ② 편두통 ③ 이전에 간질환, 담낭질환, 자궁내막암 또는 혈전색전증의 기왕력이 있는 경우

4. 갱년기의 사회, 심리적 변화

가족문제	- 배우자 : 질병이나 죽음, 정년퇴직, 불화 - 자녀 : 문제행동, 수험, 자립, 질병이나 장애 - 그 외 : 노인의 간호나 사망
직장문제	-인간관계, 책임의 증대
자기자신의 문제	- 건강에 대한 자신감 상실 - 정신과 신체의 위화 - 빈 등지 증후
기타	- 친한 사람의 병과 죽음

5. 폐경에 대한 환자의 관심

생식능력의 상실	- 여성의 생애에서 출산 역할과 관련깊음 - 자부심 또는 자기 존재 인식에 있어 큰 상실감 - 어떤 여성에게는 궁극적 피임으로서 환영받기도 함
젊음의 상실	- 에스트로겐, 콜라겐 등의 부족으로 피부 탄력 감소 - 젊음에 대한 상실감은 미묘한 고통을 줌 - 노화가 가져다주는 불안이나 우울감에 유의
피부변화	- 에스트로겐 투여 시 피부 두께가 잘 유지됨 - 에스트로겐은 소실된 콜라겐을 복구 or 소실을 예방
정서 및 행동변화	① 우울증: 가장 흔히 볼 수 있음 (20% 이상에서 동반) ② 불안증과 성냄: '갱년기증후군'

	- 폐경 무렵 특히 불안하거나 쉽게 화를 잘 내는 경향 - 이는 E부족과 연관이 없거나, E 보충으로 치료할 수 없음 - 아마도 다른 심리적 요인과 관계되는 것으로 추정 - 갱년기 시기에 자율신경 균형이 깨져있다는 보고가 있음 ③ 성욕감퇴: 안드로겐 감소와 연관있을 것으로 추정
--	---

호르몬 보충 요법 관련 연구 2가지

내용을 엄청 길게 설명하셨는데...

결국 핵심인 결론만 정리하자면 심혈관계 질환 등에 대해 에스트로젠 보충 요법을 사용하는 것은 인정되지 않는 추세다.

2절 갱년기증후군

1. 개술

- 정의: 여성의 생식능력이 감소되고 소실되는 전환시기, 즉 생식기에서 비생식기로 이행되는 기간에 나타나는 다양한 증상
- 연령: 한국 여성의 폐경은 대략 50세 전후로 보고 (가장 최근 자료는 49.9세)

2. 병인병기

- 폐경 전후에는 신기가 점차 쇠퇴하고 천기가 마르고 충임맥이 허하고 생식기능이 점차 상실되고 장부의 기능이 점점 쇠퇴하게 되므로 신체의 음양평형이 실조되어 질병에 이르게 됨
- > 갱년기 증후군의 병인, 병기의 기본은 **신허**
- 증상이 다양해 **간울, 심간화왕, 심신불교, 심비양허, 혈어** 등도 고려
- 서양의학 쪽으로는 에스트로겐 투여로 인해 꼭 교정이 되지는 않는다고 봄

3. 진단

- 45세 이상 여성이 갱년기 증후를 보일 경우, 호르몬 검사 없이도 갱년기와 폐경 진단이 가능 (단 호르몬 대체 요법 사용 시 어려울 수 있음)

1) 표면 임상진료 지침

- ① 45세 이상 여성이 월경불규칙, 갱년기 증상이 있으면 폐경 이행기로 간주

② 1년간의 무월경이면 폐경으로 진단

③ 폐경 진단을 위한 여성 호르몬 평가는 필수적이지 않음

④ $FSH \geq 40$, $E2 \leq 30$ 의 소견과 함께 6개월간 무월경이면 폐경으로 진단

2) 45세 이상 여성의 갱년기, 폐경 진단

- 45세 이상 여성의 갱년기 증후일 시, 호르몬 검사 없이도 갱년기와 폐경의 진단 가능. 정확히는 호르몬 검사로는 진단 불가능한 것.
- 단, 호르몬 대체 요법을 시행한 여성의 경우, 폐경의 진단이 어려울 수 있음을 고려

3) 폐경 진단을 위해 FSH 검사가 고려되는 경우

- ① 40-45세 여성이 월경주기 변화와 함께 폐경 증상을 보이는 경우
- ② 40세 이하 여성이 조기폐경으로 의심되는 경우

4) 실험실 검사

- $E2$: ND(검출 X) ~ $14pg/ml$
- $FSH > 40mIU/ml$
- $LH > 25mIU/ml$
- > 폐경 진단 기준

- 희발월경 상태인 여성이라고 하더라도 $E2$ 치가 $30pg/ml$ 이상이라면 난소기능이 어느정도 유지되는 것으로 볼 수 있음
- 폐경 이행기 동안 가장 일반적 소견: **혈중 FSH의 증가**
- $E2$ 정상이어도 FSH가 $10 \sim 25mIU/ml$ 정도로 증가되어 있으면 폐경 이행과정에 난소에서 FSH에 대한 저항이 생기고 있는 것으로 간주

3. 평가 방법

① 쿠퍼만 갱년기 지수

- 대표적인 갱년기 증상 점수화
- 안면홍조, 감각 이상, 불면, 신경과민, 우울증, 현기증, 피로감, 관절 통이나 근육통, 두통, 가슴 두근거림, 의주감 등의 11가지 증상
- 가장 간단하게 임상에서 활용

② 갱년기 삶의 질 평가 (MenQOL)

- 쿠퍼만 갱년기 지수를 보완하기 위해 만들어진 설문
- 혈관 운동 증상, 심리사회적 증상 등 29항목으로 구성
- 세부증상의 사전 사후변화 비교 활용에 적합

③ 갱년기 정도 평가 지수

- 갱년기 여성의 삶의 질 평가 도구
- 심리적 증상, 신체증상, 비뇨생식기 증상의 3개 영역, 총 11개 항목으로 구성

④ 여성 건강 지수

- 폐경 후기와 폐경 주위기 여성들이 경험하는 신체적, 심리적 증상 평가 도구
 - 영역별 점수가 높을수록 증상 심한 것을 의미
- 그 외에도 갱년기증상척도, 갱년기 삶의 질 척도(MQOL), UQOL, PGWB, 안면홍조/발한의 정도, Beck 우울척도, 불안척도 등 평가척도를 활용

4. 변증치료

신음허	상열감, 발한, 오심번열, 이명, 현훈, 기억력감퇴, 가려움, 월경부조	
	자양간신 육음잠양	좌귀음, 육미지황환, 지백지황환
신양허	형한지냉, 부종, 대변무름, 소변빈삭, 월경부조	
	온신장양	우귀환
신음양량허	현훈이명, 요슬산연, 수족냉, 상열감, 자한도한	
	온양장수 익양충임	좌귀환 합 이선탕
심신불교	심계, 정충, 불안, 불면, 다몽, 요슬산연, 기억력감퇴, 월경부조	
	자음강화 보신녕심	감리기제환, 감맥대조탕 합 계지가용골모려탕
간울	긴장, 우울, 가슴답답, 화를 잘 냄, 불면, 다몽, 상열감, 발한, 월경부조	
	소간해울	소요산
심비량허	심계, 천급, 불면, 상열감, 발한, 무기력, 식욕X	
	보심건비	귀비탕 - 불면증 치료용

교수님 다용 처방 꿀팁

- ① 자신청심탕: 조구등 8그램, 목단피 산약 산수유 백복령 연자심 자초 합환피 부소맥 각 5그램 - 신음허에 활용
- ② 온신영신탕: 만삼 선령비 선모 백출(초) 5그램 조구등 8그램 목단피 5그램 황기 연피 복령 방기 6그램 산약 합환피 파고지 5그램 - 신양허에 활용
- ③ 이선탕: 대표적인 보신양(선령비(음양곽) + 선모) + 보신음(당귀 파극 지모 황백) 약재
- ④ 사이오합탕: 조기폐경과 같이 치료가 어려운 무월경 ex. 쉬한증후군 사물탕(보혈) + 이선탕(보신양) + 오자연종환(보신익정)

교수님 환자 썰

갱년기 환자는 크게 둘로 나누어볼 수 있음.

1. 갱년기 증상을 줄여야 할 경우
2. 노화 줄이고 폐경을 조금 더 미루고 싶어하는 경우

생리를 이틀 정도 하는 한 환자가 왔는데 E2가 40~50 / FSH 38.4 / LH 23.6 나옴.

FSH와 LH만을 봤을 때 폐경의 진단 기준에 거의 근접함.

(E2가 0~14 사이, FSH가 40 이상, LH가 25 이상이면 폐경 기준에 해당)

신양허로 인한 무월경에 거의 근접했다고 보고 귀신환에 우귀환(발음 이슈... 확실하진 않음)을 따로 줌.

한 달 뒤 수치 다시 검사

E2 58 / FSH 5.8 / LH 4.5 / 프로게스테론 13.4

프로게스테론 13.4 = 배란이 된 것을 의미.

-> FSH와 LH 감소함.

+ 갱년기 한출과 관련해서 어떤 약을 써야 할까?

조구등은 땀을 멈춘다기보다는 진정시키는 약.

부소맥을 메인으로 쓴다.

땀과 관련된 증상이 가장 많이 발생하는게 갱년기 증후군과, 가장 난치에 해당하는 산후통에서 땀 조절이 되지 않는 경우.

갱년기 환자의 국민건강보험 청구 분석 연구

- 오적산, 가미소요산, 당귀육황탕, 반하후박탕, 회춘양격산 등을 다용
- 오적산은 근골격계 증상에 통치방

- 일본의 주요 보험 청구 제재: 가미소요산, 당귀작약산, 계지복령환, 온경탕, 온청음, 시호계지건강탕
- 대만의 주요 보험 청구 제재: 가미소요산, 지백지황환, 기국지황환, 감맥대조탕, 천왕보심단, 육미지황환, 산조인탕, 좌귀환, 소요산, 귀비탕
- 국내에서 갱년기 장애: 귀비탕 계열을 가장 다용, 이외에는 청심연자탕, 가미소요산, 인삼양영탕, 육미지황탕 순으로 다용
-

3절 갱년기환자의 관리

1. 갱년기 여성의 외래 진료

- 갱년기 환자의 적절한 임상 관리를 위하여 부인과 외래에서는 여성이 40세에 이르면 호르몬 변화에 따른 제반 문제를 평가하는 프로그램을 적용하도록 함
- 기본적으로 생리변화, 비정상 자궁출혈, 안면홍조, 불면증, 근골격계의 통증, 성기능 등을 조사
- 갱년기 환자 진료의 첫단계
- > 내원하는 환자의 동기가 증상에 대한 치료인지 또는 건강관리 목적으로 하는 예방인지 확실히 할 것
 - 급성 장애와 아급성 장애는 주로 증상의 경감에 주안점
 - 만성 장애(ex. 골다공증, 심혈관계)는 건강관리에 주안점

1) 증상의 파악

- 안면홍조, 상기갑 등의 혈관운동신경 증상이 전형적인 갱년기 증상. 그 외에는 요통, 어깨결림, 피로 등
- 일본: 안면홍조보다 요배통이 주소증인 환자가 45%
- 우리나라: **열성홍조(61%)**가 가장 많고, 심계항진, 근육관절통, 발한, 건망증 등의 순서
- 열성 홍조 등 혈관운동증상이 있는 여성의 1/3은 이로 인해 심한 pain
- 발현되는 시기에 따라 급성, 아급성, 만성 증상으로 구분 가능

2. 갱년기 장애의 분류

갱년기장애의 분류				변증	치법
급성장애	혈관운동 신경증상	A군	안면홍조(주증상), 상기갑, 수족냉증	신음허 신양허 음양량허	이선탕 좌귀음 지백지황환 or 내관, 소부, 신문 등의 침 치료
		B군	동계, 숨참, 심계항진	심신불교 간신음허	자음강화 보신녕심 자양신음 청간설열 -> 감리기제한, 자수청간음
	신경근 증상	C군	어깨결림, 두통, 요통, 관절통	간신부족 비신양허	육미지황탕가미 우귀환 합 사군자탕 가감
	정신신경 증상	D군	안절부절못 함, 불안감, 불면, 무력	간울 심비량허 심담허겁	소요산, 귀비탕, 온담탕
아급성장 애	피부자각 증상	E군	피부건조감 , 벌레가	폐음허 음허혈조	육미지황환 가 맥문동, 오미자,

			기는 듯한 느낌, 손발 저림		하수오, 백선피 기국지황당가감
	질위축 증상	F군	질건조감 성교통 성욕저하	음허정휴	귀신환, 좌귀음
	방광요도 위축증상	G군	빈뇨, 요실금	신기불고	금쇄고정환
만성장애	고지혈증, 골다공증, 심혈관질환 위험성 증대				

A군

- 증상은 반복적이고, 일시적인 홍조, 발한 및 열감이 심계항진, 불안감, 오한과 가끔 동반됨
- 안면홍조 시 발한이 동반되는 이유는 중심체온을 낮추기 위함 -> 열이 식음
- 폐경 여성에서 야간의 안면 홍조와 발한은 수면을 방해하며 정상 수면 리듬을 깨지게 함

1) 급성 갱년기장애

혈관운동 신경증 상	A군	- 안면 홍조가 주증상, 상기감, 수족냉증 등의 증상이 동반 - 증상은 반복적이며, 일시적인 홍조, 발한, 열감, 심계항진, 불안감과 오한(땀이 식으면서 나타남)이 가끔 동반 - 야간의 안면 홍조와 발한은 정상 수면
------------------	----	--

		리듬을 방해
	B군	- 심계항진, 동계, 숨참이 주증상 - 안면홍조와 함께 주로 동반되어 많이 나타나는 증상 - 심신불교, 간신음허로 변증 - 보통 A군이나 B군 하나만 주소증으로 오기보다는 같이 호소하는 경우가 많음
신경근 증상	C군	- 어깨결림, 두통, 요통, 관절통이 주 증상 - 약물요법 이외에 침치료, 물리치료 병행 - 간신부족이나 비신양허로 변증 - 요통이 주라면 오적산 계열 사용 - 관절통이면 허증성 관절통 약 사용
정신신경 증상	D군	- 불면, 불안, 무기력, 안절부절 못함이 주증상 - 폐경기에는 수면장애, 불면이 흔함 (소요산, 귀비탕, 온담탕, 귀비온담탕) - 25-50%에서 심리증상, 특히 우울이 나타남 - 간울, 심비양허, 심담허겁 등으로 변증

2) 아급성 갱년기장애

피부자각 증상	E군	- 피부건조감, 벌레가 기는 듯한 느낌, 수족의 저림이 주 증상
------------	----	-------------------------------------

		- E 분비 감소 → 피부의 수분, 히알루론산 및 콜라겐 감소 → 피부 건조 - 폐경 초기부터 급격히 나타나서 첫 5년 동안 콜라겐의 30% 소실, 그 후 20년간 매년 2.2% 감소
질위축 증상	F군	- 질건조감, 성교통, 성욕저하가 주증상 - E 결핍으로 질 상피 표피세포 소실 → 외부자극에 취약하여 출혈 - 귀신환, 좌귀음 등을 활용
방광요도 위축 증상	G군	- 배뇨장애, 긴급배뇨, 재발성 요로감염이 주증상 - 진성 긴장성 요실금도 여성호르몬 부족과 관계 - 요로가 짧아짐으로 인해 긴장성 요실금 발생 - 폐경 이후 방광과 요로 상피 세포 감소 및 얇아짐에 따라서 발생

3) 만성 갱년기장애

골다공증	개요	- 골의 화학적 조성에는 변화가 없고, 단위용적 내의 골량감소를 초래하여 경미한 충격에도 쉽게 골절이 일어나는 질환 - 가장 흔한 골대사성 질환으로, 나이가 들수록 빈도 증가 - 막연한 요통 외에 뚜렷한 자각 증상 없음
	원인	- E 결핍으로 인한 골 재흡수 증가 (E는 골의 재흡수를 지연시키고 성장판을 닫아주는 역할)

		- 영양결핍에 의한 칼슘 및 인 대사장애, 골성숙 결합 (혈중칼슘 부족하면 뼈에서 칼슘을 끄집어냄 -> 골다공증 발생) - 칼슘을 최소 700mg에서 1200mg 정도는 섭취해야함 -> 유제품 섭취가 가장 good
	경과	- 폐경 이후 골질은 연간 1~2% 감소 - 처음 5~7년 사이에 골밀도 20% 소실 - 60세 이상 여성의 25%는 X-ray에서 골다공증 소견
	고위험군	- 조기폐경 또는 조기난소 절제, 마르고 골격이 작고 비활동적인 사람, 골다공증 가족력, 미산부, 갑상선·부갑상선 기능 항진증의 이환, 칼슘섭취가 적거나 위장관 질환 또는 절제 등으로 흡수 적은 경우, 과도한 흡연, 음주, 카페인 소모, 간질환, 햇빛, 비타민D 부족, (+서양인보다 동양인)
	골밀도 측정	- 골밀도 측정이 골다공증 진단에 가장 유용한 방법 - 검사방법 : RA, DEXA, 정량적 초음파, 정량적 전산화 단층촬영 - 가장 정확한 것은 EDXA와 정량적 전산화 단층촬영 - 골밀도는 T-값으로 표현 - 정상: 1 ~ -1 / 골감소증: -2.5 ~ -1 / 골다공증: -2.5 이하 - 심한 골다공증은 T-값이 -2.5 미만이면서

		하나 이상의 골절을 동반한 경우
심혈관계 질환	개요	- 관상동맥질환, 뇌혈관질환 포함 - 50대 이상 여성의 모든 사망 원인의 50% 상회
	원인	- E 부족 - 저에스트로겐증 외에는 고혈압과 흡연이 가장 위험한 요소
	역학	- 50세 이상 여성 사망원인의 50% 이상 - 폐경 전에는 남성의 사망위험도가 높지만, 폐경 이후에는 역전됨

- 골다공증 추가 내용 -
- 녹용이 골밀도를 증가시키는 데에 좋음
- 보신지재하는 약물(ex. 자하거, 귀신환), 삼출건비탕, 활혈거어 약물 등도 꽤나 효과가 좋음

5. 폐경기 여성의 자궁출혈

1) 원인

① 기질적 원인

- 자궁경부 용종, 자궁내막 용종, 자궁근종, 자궁섬근증(=자궁선근증), 용모성 질환, 자궁내 피임장치, 생식기암, 혈액질환

② 기능성 자궁출혈

- 황체호르몬에 의해 억제되지 못하는 E에 의해 소퇴성 또는 파탄출혈이 흔히 일어남

2) 치료

① 기질적 원인

- 원인치료 시행

② 기능성 자궁출혈

- 소량 내지 중등도의 경우는 우선 관찰의 대상
- 반복 출혈할 경우, 헤모글로빈 변화와 관계없이 치료
- 소파 수술이 일단 필수적
- 조직 소견상 기능성 출혈이 확실하면 소파 수술로 40~70% 치료 가능

※ 자궁출혈 치료의 기본원칙

① 급성출혈의 지혈

② 재발의 방지와 정상 월경주기의 회복

③ 악성질환 배제

6. 갱년기의 정신질환

1) 갱년기 우울증

- 젊었을 때는 우울증으로 고생한 적이 없다가 갱년기에 처음 발생하는 우울증

- 증상

- 중심증상: 초조, 불안, 안절부절 못하는 초조성 우울
- 적대적인 태도, 심한 절망, 극도의 후회, 비현실감, 건강염려증, 허무망상이 나타나기도 함
- 주로 여성에게 나타나지만 남성에게도 나타날 수 있고, 사회 계층이 낮거나 이혼한 집단에서 발생 가능
- 빈둥지 증후군(Empty nest syndrome)
대화할 시간이 줄어든 남편과의 관계로 인해 혼자 빈집을 지키며 공허를 느끼게 되는 빈둥지 증후군의 증상

- 치료

- 증상이 다양해 많은 것을 고려 필요
- 높은 자살을 고려하고 감별진단을 위해 입원 치료가 원칙
- 호르몬 보충 요법은 치료에 도움 X

- 한의학 치료

- 환자의 체질, 증상, 환자의 건강상태 등을 중심으로 변증치료
- 온담탕 가감, 시호가용골모려탕 가감, 감맥대조탕 합 이공산, 귀비탕, 반하백출천마탕 가감

2) 갱년기 망상상태

- 갱년기에 망상을 중심으로 하는 정신장애가 나타나는 것
- 정신분열증과 달리 망상 이외에 행동의 이상이나 그 외에 부수적인 증상 없음
- 망상은 잘 체계화되어 있고 정신분열보다 덜한 상태
- 치료의 시작도 쉽지 않고, 치료가 시작되더라도 예후가 좋지 않음